CHOC SEPTIQUE

Diagnostic : Hypotension systolique <90 mm Hg réfractaire au remplissage associée à une lactatémie > 2 mmol/L dans un contexte de sepsis

Bilan de sévérité et de retentissement sur les organes

NFS, plaquettes, iono. sg, urée créat., bilan hépatique, calcémie

RP – ECG – GDS

Bilan étiologique

Interrogatoire et examen clinique complet

RP – Hémocultures – ECBU

Prélèvement microbiologique guidé par la porte d'entrée suspecté

Traitement

Symptomatique

- Remplissage vasculaire par cristalloïdes NaCl 0.9% entre 20 et 30 ml/Kg dans les 3 premières heures
- Noradrénaline sur VV périphérique puis centrale. Débuter à 0.1 µg/Kg/min et doubler la posologie toutes les 10' pour une cible de PAM à 65 mm Hg.
- Surveillance de la Fc, de la pression artérielle de la SpO2 et de la diurèse.
- Surveillance des signes d'hypoperfusion et monitoring GDS et lactates

Etiologique

Par ordre de fréquence :

1) La porte d'entrée est le plus souvent pulmonaire (50%), puis digestive et rénale

2) Ttt antibiotique : bi antibiothérapie IV (incluant en général une beta-lactamine) en tenant compte du caractère communautaire ou associé aux soins. Ne pas adapter les posologies pendant les 24 premières heures en cas d'insuffisance rénale.

3) Traitement chirurgical ou drainage s'il y a lieu

Pronostic : Mortalité entre 40 et 50 %

Transfert en Réanimation le plus rapidement possible